EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL : HOSPITAL DE SAN CARLOS N° EGRESO : 75777
SERVICIO : MEDICINA HSC
FECHA : 2023-12-14 12:45:00

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre	: MARIO EDMUNDO CERDA PACHECO			RUN	: 5.911.839-0
F.Nac	: 28-02-1947	Edad	: 76 AÑOS, 9 MESES	Género	: Masculino
Dirección	:			Comuna	: SAN CARLOS
Previsión	: SIN INFORMACION	Teléfono	: 0		
Fecha Ingreso	: 2023-12-11	Fecha Egreso	: 2023-12-14 12:45:00	Causal	: MEDICA
Condición	: VIVO	Destino	: HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA	Derivación	:

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. E87.1-HIPOSMOLARIDAD E HIPONATREMIA

DIAGNOSTICO(S) EGRESO

IRB NEUMONIA BASAL EN REMISION
DIABETES MELLITUS TIPO 2 IR
HIPERTENSIÓN ARTERIAL
ACV SECUELADO
HERPES ZOSTER
POSTRACIÓN

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. J18.0-BRONCONEUMONIA, NO ESPECIFICADA (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)

COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

Paciente es traido por SAMU el 09/12 que acude a llamado de familiar que refiere episodios de hipoglicemia recurrentes secundario a hipoalimentación debido a trastorno de deglución de 3 dias de evolución, hoy el cuadro se exacerba con tos productiva y alteración del estado de conciencia, SAMU pesquisa hipoglicemia 35 mg/dl, en triage administran 3 ampollas glucosa 30% . Al examinar a paciente se observan lesiones herpéticas en hombro y región dorsal izquierda. Pulmonar sin uso de musculatura accesoria, crépitos difusos. En exámenes de ingreso destaca: glic 233 creat 1.1 alb 3.1lact 1.2 pcr 66.1, elp (na/k/cl): 110/3.4/81, hb/hcto: 7.5/20.9 plaq 143000 leuc 4000, gsa: ph 7.43 po262.9 pco229.1 fio2 28% pafi= 225 mmhg/orina completa no inflamatoria, urocultivo negativo. Rx de torax: Infiltrados difusos en ambos campos pulmonares. Se ingresa con hiponatremia severa, durante su estadía en urgencias, se pesquisa parámetros infecciosos al alta, hemodinámicamente estable, sin fiebre., evoluciona de manera satisfactoria con paramnetros a la baja sin embargo con tac que reporta IRB + pielonefritois, y dilatacion de via biliar con hoja hepatica normal, motrivo pro el cual en vista de m,ejroia clinica y paraclinica se decide alta con hodom con atb.

PLAN DE MANEJO:

ceftriaxona hasta completar 10 dias y aciclovir hasta completar 14 dias
kine resp + motora

INDICACIONES AL ALTA

1. FENITOINA COMPRIMIDO 100 MILIGRAMOS 1 comprimido cada 12 hrs. por 30 dias via ORAL
2. OMEPRAZOL COMPRIMIDO 20 MILIGRAMOS 1 comprimido cada 24 hrs. por 30 dias via ORAL

3. ENOXAPARINA AMPOLLA 40 MILIGRAMOS 1 ampolla cada 24 hrs. por 6 dias via SUBCUTANEA
4. CARVEDILOL COMPRIMIDO 25 MILIGRAMOS 0.5 comprimido cada 12 hrs. por 30 dias via ORAL
5. QUETIAPINA COMPRIMIDO 25 MILIGRAMOS 2 comprimido cada 24 hrs. por 30 dias via ORAL
6. CEFTRIAXONA FRASCO 1 GRAMO 2 frasco cada 24 hrs. por 6 dias via INHALATORIA
7. ACICLOVIR COMPRIMIDO 400 MILIGRAMOS 1 comprimido cada 6 hrs. por 14 dias via ORAL
8. IPRATROPIO INHALADOR FRASCO UNIDAD 2 PUFF C 12HRS
9. SALBUTAMOL INHALADOR 100 MICROGRAMOS / DOSIS 2 puff cada 6h

EXÁMENES Y RESULTADOS

hmc negativos a la fecha
Creatinina : 0,60 * mg/dl
Nitrógeno Ureico : 14 mg/dL
Uremia : 30 mg/dl 19 - 43
Sodio (Na) : 138,00 mmol/L
Potasio (K) : 3,80 mmol/L
Cloro (Cl) : 111,00 * mmol/L

Control en: 30 días en HOSPITAL DE SAN CARLOS

Ronald Carlos Jose Acero Serrano
MEDICO TRATANTE
27840838-8

JEFE SERVICIO